PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

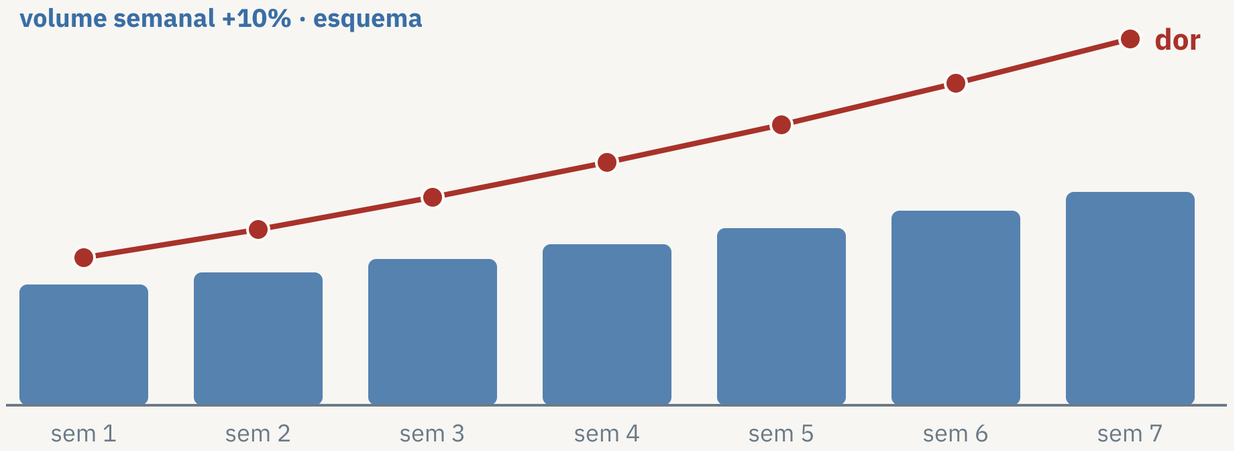
Progressão de carga

Cinco erros de dose em tecido em cicatrização

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

A CONDUTA QUE PARECE PRUDENTE

Dez por cento por semana, religiosamente, há sete semanas. E piorando.



Um corredor voltando de tendinopatia de Aquiles

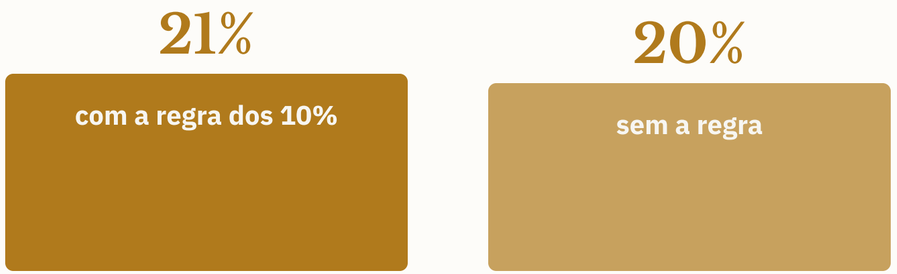
? O que a regra não diz

- sobre o que se calculam os dez por cento
- o que mais mudou naquela semana

O QUE A EVIDÊNCIA DIZ DA REGRA

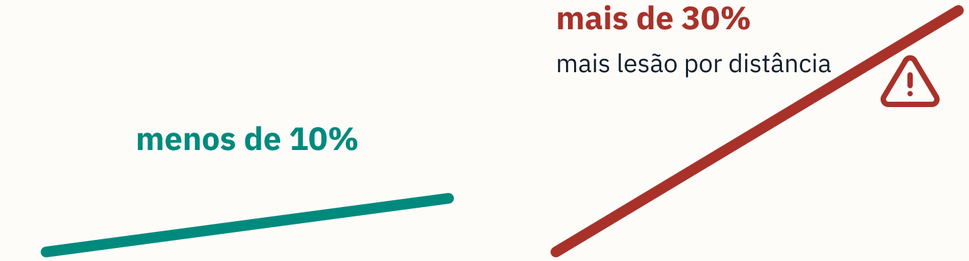
Saltos grandes preocupam; a regra sozinha não protegeu

Ensaio de 2008 · 486 iniciantes sorteados



lesionados

Coorte de 2014 · 874 iniciantes com GPS



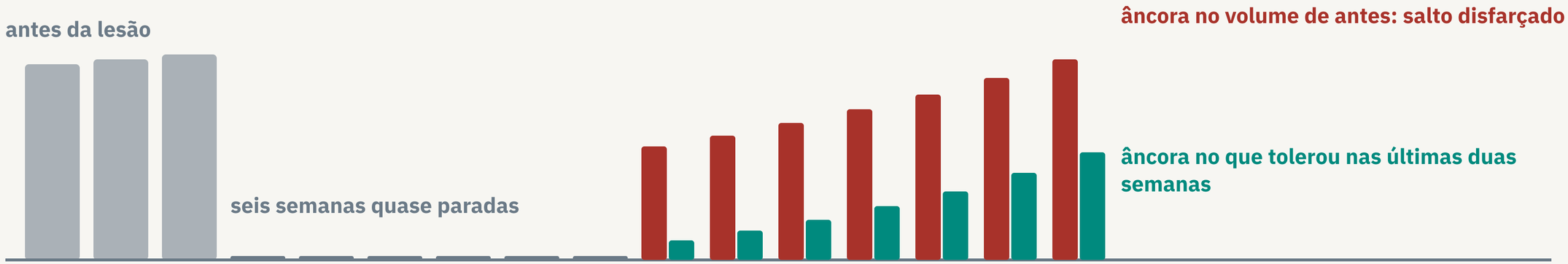
aumento de distância em duas semanas

> Boa heurística de conversa, não lei. E dá para errar respeitando-a à risca.

Am J Sports Med 2008 · J Orthop Sports Phys Ther 2014

ERRO UM

A âncora errada

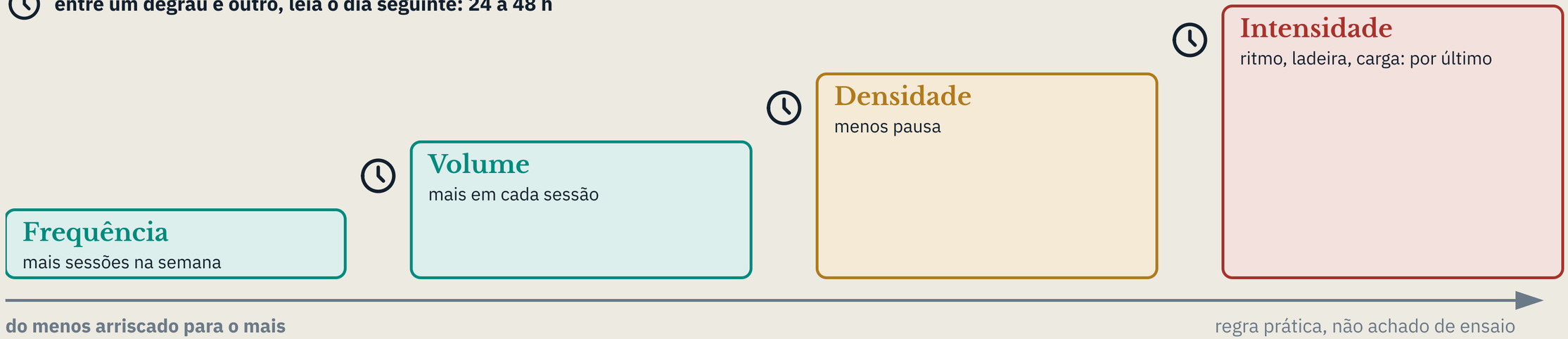


> A base é o que a pessoa fez, sem piora, nas últimas duas semanas. Não o que fazia antes da lesão.

Esquema, sem valores medidos

Uma variável por vez, nesta ordem

entre um degrau e outro, leia o dia seguinte: 24 a 48 h



Os quatro elementos de um degrau

Estímulo

elevação de calcanhar numa perna só, 3 séries, 2 repetições antes da falha

Dose

quantas vezes por semana, com que carga

Critério de saída

o que precisa acontecer para subir: as repetições combinadas, sem dor no dia seguinte

Critério de regressão

o que faz voltar um degrau: dor no dia seguinte bem acima do habitual, ou inchaço de volta

o mais importante e o menos escrito

ERRO QUATRO

Parar tudo quando piora

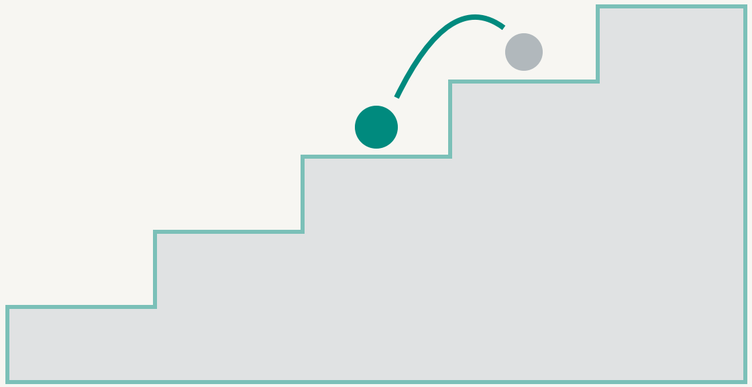


> A resposta a uma piora é ajustar a carga, não retirá-la: a carga ótima das siglas do primeiro atendimento vale aqui também.

Br J Sports Med 2012

A IDEIA DA AULA

Uma piora é um degrau para baixo, não uma queda da escada.



Degrau para baixo

regressão escrita antes
volta um passo por poucos dias
e sobe de novo dali

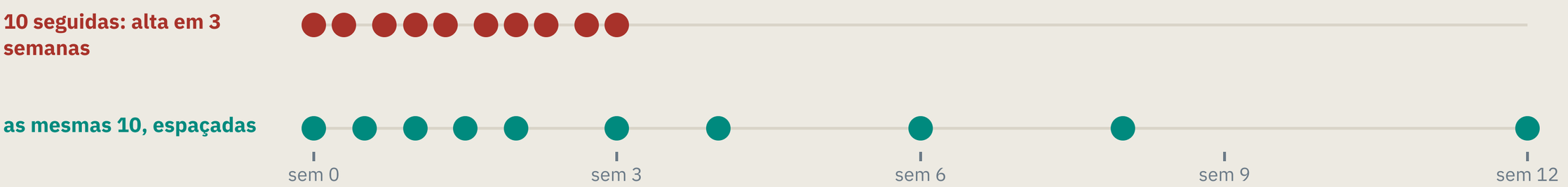
Queda da escada

sem plano: para tudo
e recomeça do zero



> A piora vai acontecer; no tendão, quase sempre. A diferença está em a pessoa saber, antes, o que fazer quando ela chegar.

O mesmo número de sessões, cobrindo doze semanas



Primeiras sessões para ensinar e calibrar, programa escrito, revisão com data. Alta sem data de revisão é abandono agendado.

Esquema, sem valores medidos

O registro de cinco colunas

Data	O que fez	Carga ou volume	Dor durante (0–10)	Dor em 24 h (0–10)
seg	trote e caminhada	20 min	2	2
qua	trote e caminhada	25 min	2	3
sex	**trote com ladeira**	25 min	3	6

na sexta entrou a ladeira, e a dor do dia seguinte subiu

> Sem registro, a consulta traz memória, puxada pelo último dia ruim. Com registro, a pessoa costuma achar o padrão antes de você.

Linhas ilustrativas

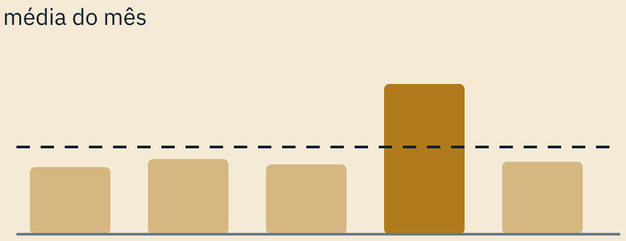
Três princípios para a reabilitação

A base protege



carga crônica bem construída tolera mais

O pico importa



a semana em que dobrou pesa mais que a média do mês

Carga não é só treino



sono, trabalho, estresse e doença entram na conta

> O índice agudo e crônico não serve como número de decisão; o módulo de preparação física volta a ele.

Br J Sports Med 2016 · consenso do COI 2016

JUNTANDO

Cinco erros e o que fazer no lugar

Âncora errada	progredir sobre o que tolerou nas últimas duas semanas
Duas variáveis juntas	uma por vez: frequência, volume, densidade, intensidade
Degrau sem condição	estímulo, dose, critério de saída e de regressão
Parar tudo quando piora	regressão escrita antes: um degrau para baixo
Alta administrativa	sessões espaçadas, programa escrito, revisão marcada

Por baixo dos cinco, o registro

PROGRESSÃO DE CARGA

Nada disso acelera o tecido. Só para de atrapalhá-lo.

- ✓ Base real, uma variável por vez
- ✓ Degraus com critério de saída e de regressão
- ✓ Registro e revisão marcada

Fisioterapia

Escreve os degraus e os critérios.

Preparação física

Traz a base real e assume no campo.

Médico

Traduz “repouso relativo” em carga.

Próxima aula: a reconstrução do cruzado anterior, num caso ilustrativo.